

06 - 06- Les Infections associées aux soins IAS - Pr. TASSI

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui est intitulé les infections associées aux soins. Alors, les objectifs de ce cours, c'est de reconnaître une infection associée aux soins, d'adopter les mesures nécessaires pour prévenir ces infections aux soins, de reconnaître les cinq indications à l'hygiène des mains, pratiquer le type d'hygiène des mains adaptée à chaque situation et utiliser correctement les précautions d'hygiène standard et les précautions complémentaires. Les infections associées aux soins sont des infections contractées lors de la prestation de soins de santé et ce sont des événements indésirables le plus fréquemment rencontrés dans les soins de santé et qui sont responsables d'une mortalité et d'une morbidité élevée.

Aussi, l'écho de leur prise en charge est considérable et, du fait de la résistance accrue des agents pathogènes responsables de ces infections, il est donc important de les identifier et de les connaître pour le choix du traitement convenable, pour les signaler et les surveiller afin d'instaurer les mesures nécessaires pour les prévenir et pour gérer le risque infectieux au milieu de la maladie. C'est un cours qui commence par plusieurs définitions qu'il faut comprendre avant de passer et progresser dans le cours. On appelle « infection associée aux soins » toute infection qui survient au cours ou à la suite d'une prise en charge qui peut être diagnostique, thérapeutique ou préventive.

Pour une prise en charge diagnostique, on a l'exemple d'une cystoscopie qui a été réalisée dans le bilan d'une hématurée terminale pour suspicion par exemple d'une tumeur de la vessie et le patient développe par la suite une infection urinaire. C'est la cystoscopie qui a inoculé au patient un germe pour lequel il développe cette infection urinaire par la suite. Comme une prise en charge thérapeutique qui peut se compliquer d'une infection associée aux soins, on a par exemple un patient qui est opéré pour une cholecystectomie pour l'ITS de la vésicule biliaire et qui développe par la suite une infection de la paroi.

Comme action préventive suite à laquelle le patient peut développer une infection associée aux soins, par exemple un patient qui présente une infection du site après l'administration d'un vaccin. Deuxième condition nécessaire à la définition de l'infection associée aux soins, c'est que cette infection n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Les infections associées aux soins regroupent deux entités.

Il y a les infections nosocomiales, ce sont des infections secondaires aux soins qui étaient contractées dans un établissement de soins qui peut être un hôpital, un centre hospitalier universitaire ou une clinique privée. Deuxième entité, ce sont des infections associées aux soins contractées lors d'un soin réalisé en dehors d'un établissement de santé. C'est peut-être un soin réalisé à domicile, dans un cabinet ou dans une maison de retraite ou autre.

Toujours dans les définitions, pour parler d'infection associée aux soins, il faut qu'il y ait un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation par rapport à l'acte de soin

impliqué dans la survenue de l'infection associée aux soins ou par rapport à l'hospitalisation quand il s'agit d'une infection nosocomiale. Selon le site anatomique, une infection associée aux soins du site opératoire, c'est toute une infection du site opératoire qui apparaît dans les 30 jours après l'intervention. Mais quand il s'agit de la mise en place d'un implant ou d'une prothèse, une infection associée aux soins peut survenir au cours de l'année suivant l'acte opératoire.

Il faut aussi apprécier dans chaque cas la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection, c'est-à-dire le degré d'implication de l'agent pathogène retrouvé et de l'infection en cause, et ça sera beaucoup plus clair quand on fera des exercices lors du cours. Il existe deux catégories d'infections associées aux soins, les infections associées à l'environnement de soins et les infections associées aux actes de soins. Et ces deux entités, on va les voir ultérieurement.

L'infection associée aux soins liées à l'environnement ne concerne pas que les patients malades ou non, mais aussi les professionnels de santé, médecins, infirmiers, les étudiants et les visiteurs pour qui, rien que leur présence en milieu de soins, sans recevoir et bénéficier des soins, les expose à être victime d'une contamination par des agents pathogènes présents dans cet environnement qui peuvent provenir du patient ou d'autres. Par exemple, la présence au niveau de l'environnement de soins d'infection comme la grippe expose patients et non-patients. La présence de l'aspergillose au niveau de l'environnement peut contaminer des patients notropéniques au niveau de l'hématologie.

La présence de la légionellose dans les réseaux d'eau d'un hôpital peut aussi être responsable de cette infection chez certains malades prédisposés. Deuxième catégorie d'infection associée aux soins, c'est l'infection associée à l'acte de soins, c'est-à-dire cet acte de soins peut être pris au sens large c'est-à-dire peut inclure même l'hébergement et le nursing. Par exemple, un drap contaminé peut être responsable d'infection associée à l'acte chez le patient.

Le soin réalisé peut être fait aussi bien par un professionnel de santé que ce soit le médecin ou l'infirmier ou par même un autre comme l'étudiant en médecine, l'étudiant-infirmier qui sont encadrés par un professionnel de santé et ce soin peut être un simple poncement, la mise en place d'une perfusion, une injection intramusculaire, un sondage physique à l'autre. Ce soin qui est prodigué peut être réalisé aussi bien par le patient à domicile comme par exemple la dialyse peritoneale, l'injection d'insuline et l'infection associée à l'acte de soins peut être effectuée même en dehors d'un établissement de soins. On exclut de la définition des soins une infection qui était présente ou en incubation à l'admission ou à la réalisation du soin suspect, les colonisations asymptomatiques, c'est-à-dire présence de germes sans qu'il y ait des signes cliniques témoignant de l'infection, un soin autoprescrit, c'est-à-dire prescrit par le malade et adopté par le malade lui-même sans qu'il y ait une prescription médicale derrière, par exemple la réalisation de saignées sans que ce soit indiqué par le médecin et aussi les infections materno-fétales qui sont des infections neonatales qui surviennent chez le nouveau-né d'une manière précoce dans les trois jours et avant le septième jour à partir de germes maternels qui peuvent se déclarer chez le nouveau-né alors que la maman n'a pas encore quitté l'hôpital suite à l'accouchement.

Les agents pathogènes qui peuvent causer des infections associées aux soins sont variables. Ils peuvent être des bactéries, des virus, des mycoses, des parasites ou des prions. Les prions, ce sont des agents pathogènes constitués d'une protéine qui ne dispose pas d'acide nucléique comme support génétique et qui sont responsables d'encéphalopathies sub aegus, prioniques, formes transmissibles.

Les infections associées aux soins, on peut les retrouver dans n'importe quel service au niveau de pédiatrie, du service de neonatologie, au niveau de la réanimation où il y a beaucoup de gestes invasifs, au niveau du bloc opératoire ou simplement lors d'une manipulation dans une voie veineuse ou d'administration du médicament à travers une voie veineuse. Il est obligatoire de surveiller et de prévenir les infections associées aux soins et pour cela, plusieurs intervenants participent à cette action. On a le comité de lutte contre les infections nosocomiales, le directeur de l'hôpital, la direction de l'organisation de soins, la direction de la qualité, le comité de médicaments avec le référent des anti-infectieux, le pharmacien, le laboratoire de microbiologie, le service d'hygiène hospitalière qui participent tous à la surveillance et à la prévention de l'infection associée aux soins.

Comment alors peut-on surveiller l'infection nosocomiale ? Pour cela, on peut réaliser deux types d'études, l'étude de prévalence ou l'étude d'incidence. Pour les deux études, on doit compter et les patients ayant une infection nosocomiale et les patients non infectés. Ainsi, pour l'étude de prévalence, c'est une étude instantanée, c'est comme une photo prise à un moment donné de la situation un jour donné, où on va compter les patients ayant une infection nosocomiale rapportée sur toute la population, tous les patients hospitalisés le jour même et c'est un rapport exprimé en pourcentage.

Pour l'étude d'incidence, on va faire la même chose, c'est-à-dire le nombre d'infections nosocomiales enregistrées sur le nombre total des malades au cours d'une durée déterminée qui peut être une semaine ou un mois ou une année. Pour prévenir les infections associées aux soins, on a besoin de respecter les précautions standards qui sont les précautions à prendre obligatoirement dans un milieu de soins comme l'hygiène des mains, la porte des bavettes, la désinfection correcte du matériel du soin. On a aussi les précautions complémentaires, ce sont des précautions supplémentaires selon en fonction de germes en cause, c'est comme la prévention de transmission, c'est une prévention de transmission adaptée aux germes en cause, l'isolement sélectif et protecteur des patients, la surveillance des infections nosocomiales, l'utilisation rationnelle et adaptée des antibiotiques, l'interdiction d'accès aux visiteurs et personnels, ces infections respiratoires ou maladies transmissibles, l'utilisation de plantes et de fleurs quand il s'agit de malades immunodéprimés au niveau de la réanimation, au niveau de l'hématologie.

Commençons par les précautions standard d'hygiène. Les précautions standard d'hygiène sont un ensemble de mesures à adopter sur milieu de soins afin de réduire la transmission des agents

infectieux entre soignants, soignés et en environnement et cela quel que soit le soin prodigué et le statut infectieux du patient. Aussi, ce sont des précautions à prendre lors d'une exposition à produits biologiques d'origine humaine, que ce soit le sang, les sécrétions et les excréments.

Ces mesures doivent aussi être pratiquées par tout professionnel de santé, quel que soit le soin prodigué et en tout lieu. Nous allons voir l'hygiène des mains qui est un pilier très important des précautions standard. L'hygiène est définie comme étant un ensemble de principes et de pratiques tendant à préserver et à améliorer la santé au niveau hospitalier.

Ces mesures permettent d'éviter la transmission des micro-organismes en agissant sur la propreté, la salubrité, la dispensation des soins, la chaîne alimentaire, les comportements individuels et collectifs. L'hygiène des mains a été instaurée après les travaux de Sam Lewis qui est un médecin qui était responsable de deux salles d'accouchement, de deux services de maternité avec deux salles d'accouchement dont l'une était prise en charge par les sages-femmes qui assuraient l'accouchement et la deuxième salle était où travaillaient les étudiants en médecine avec les médecins. Et il a remarqué un taux élevé d'infection post-péréale.

30% dans la salle ont exercé les étudiants en médecine contre 2% dans la salle où exerçaient les sages-femmes. Et la remarque aussi c'est que les étudiants en médecine qui travaillaient dans cette salle-là provenaient directement d'une séance de dissection sans lavage des mains. Et il a conclu qu'il y a peut-être des agents pathogènes transmis par les mains et il a instauré l'hygiène des mains des deux responsables de la salle, que ce soit les sages-femmes ou les étudiants en médecine.

Et cette hygiène des mains était réalisée par le lavage, par l'horreur de chaud. Et par la suite, il a remarqué que la mortalité est la baissée, la mortalité péréale est la baissée dans les deux salles-là allant de 30 à 2% jusqu'à 0,23% dans les deux salles. L'hygiène des mains c'est un traitement des mains par un savon liquide non médicamenteux ou pour un produit un savon, un gel ou une solution ayant un spectre d'activité antimicrobien ciblé sur le micro-organisme de la flore cutanée afin de prévenir l'infection.

L'hygiène des mains c'est le geste le plus important pour lutter contre les infections liées aux soins puisque 60 à 80% des infections nosocomiales sont d'origine maniportée. La peau est une barrière naturelle qui préserve des agressions extérieures mais qui est colonisée par une flore résidente qui fait partie de cette barrière naturelle mais aussi, elle est colonisée aussi par une flore. La flore résidente est constituée d'espèces bactériennes présentes de façon prolongée voire permanente sur la peau.

Ce sont des germes commençaux qui se situent au niveau des couches superficielles ou profondes composées de bactéries aërobées principalement de cocci grains positifs présents dans les follicules pilosébacées comme le staphylocoque. Cette flore varie qualitativement et quantitativement d'un site à un autre et d'un individu à un autre et se renouvelle régulièrement. Il

a une faible virulence mais un geste invasif peut la modifier et induire un processus La flore transitoire ou superficielle est constituée d'une flore non adaptée aux conditions écologiques de l'épiderme.

Ainsi, ils ne peuvent pas s'y multiplier et leur séjour à la surface de l'épiderme est bref. Il s'agit de germes provenant de l'environnement qui s'profitent comme le pseudomonas. Parfois ces bactéries pathogènes ou commensales issues de la flore commensale des patients soignés, de leurs tubes digestifs comme Klebsiella par exemple ou de leur portage ORL et se transmettent facilement d'un individu à un autre responsable d'infections croisées, nosocomiales, maniportées à l'hôpital.

C'est une flore qui varie au cours de la journée selon les activités. Elle reflète l'écosystème hospitalier en particulier les bactéries multirégulaires. Ici, selon l'Organisation mondiale de santé, il y a cinq indications à la pratique d'hygiène des mains.

La première c'est avant le contact avec le patient, la deuxième avant le geste aseptique, la troisième après le risque d'exposition à un liquide biologique, le quatrième après le contact avec le patient et le cinquième, c'est après le contact avec l'environnement du patient. Ici, pour les indications de l'hygiène des mains, on a des exemples de situations. Par exemple, au niveau de la situation 1, avant le contact avec le patient, on appelle contact.

Simple fait de serrer la main d'un patient, de l'aider à bouger ou de l'examiner. Donc, ces situations doivent être précédées par une hygiène des mains. Et après le contact par le patient, situation numéro 4, des exemples, c'est-à-dire après avoir serré la main d'un malade, de l'aider à bouger ou de l'examiner cliniquement, il faut procéder à l'hygiène des mains.

Dans ce tableau, on explique l'utilité de l'hygiène des mains dans ces cinq indications. Dans la première situation et la deuxième, le but de l'hygiène des mains, c'est de protéger le patient des germes transportés par les mains du professionnel, mais aussi des germes qui peuvent être ses germes à lui et d'empêcher leur pénétration lors de la réalisation d'un geste invasif aseptique. Mais dans la troisième situation, la quatrième et la cinquième, l'hygiène des mains est là pour l'utilité de protéger le professionnel de santé et l'environnement des germes provenant du patient.

Donc, l'hygiène des mains a double intérêt protéger le patient, mais aussi protéger l'environnement et le soignant. Dans les types d'hygiène des mains, on a le lavage simple, le lavage antiseptique, le lavage chirurgical, le traitement hygiénique des mains par friction qui contient la friction hygiénique des mains et la friction chirurgicale des mains. Ici, c'est un tableau comparatif des différentes techniques d'hygiène des mains.

Ainsi, sur l'élimination de la flore transitoire, le savon simple permet d'éliminer 90%. Par contre, le savon antiseptique élimine plus, jusqu'à 99,9%. Et la solution hydroalcoolique élimine un peu plus que ça, c'est-à-dire 99,999%.

Pour la flore résidente, il n'y a aucun effet du savon simple. Par contre, le savon antiseptique permet d'éliminer 50% et la solution hydroalcoolique permet d'éliminer plus, jusqu'à 99% de la flore résidente. Si la solution hydroalcoolique ne permet pas d'éliminer les soyeurs, contrairement à ça, il y a le savon antiseptique et le savon simple qui permettent de les éliminer.

Donc, la règle, c'est que on n'utilise pas des produits hydroalcooliques que sur des mains propres. Le caractère irritatif du produit, on a le savon antiseptique, il est beaucoup plus irritant que le savon simple et moins irritant, il y a la solution hydroalcoolique qui est bien tolérée. Pour une hygiène correcte et efficace des mains, il faut respecter certaines règles.

Portez des manches courtes, il ne faut pas que votre chemise ou votre blouse arrivent jusqu'à vos mains, il faut que les manches soient retroussées. Les angles doivent être courts et on dit court quand le blanc de votre angle ne doit pas dépasser 0,5 mm. Sans vernis, parce que même si l'aspect du vernis est joli, c'est une niche pour la multiplication des bactéries qui échappent à l'hygiène des mains.

Et aussi, pas de faux angles. Aussi, il ne faut pas que vous portiez de bijoux lors de votre activité de soin. On appelle bijoux, montre, bague, bracelet, mais même s'il s'agit d'une bague d'alliance sans motif, avec une surface qui y glisse.

Ici, on a fait l'expérience de mettre en culture des bagues portées par des professionnels de santé dans des boîtes de culture, après la réalisation d'un lavage au savon d'eau, à gauche, et après la réalisation d'une friction par solution hydroalcoolique à droite. Et voyez que dans les deux boîtes de culture, il y avait une poussée bactérienne, ce qui veut dire que les bijoux que vous portez sont contaminés quel que soit le type et la technique d'hygiène des mains que vous pratiquez, d'où l'intérêt de les ôter et de les enlever en milieu de soin et avant chaque technique d'hygiène des mains. Donc ici, on va expliquer chaque type d'hygiène des mains, ses techniques, ses indications et sa durée.

Commençons par le lavage simple, c'est-à-dire le lavage avec un savon doux. Donc ça doit être un savon dans un flacon avec un distributeur et pas un morceau de savon parce que c'est un lieu de pulvérisation microbienne. Alors le lavage simple permet de réduire la flore transitoire, les soyeurs et les squames cutanées.

Donc, il est indiqué avant de prendre son service, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans le service pour commencer le travail, après être mouché ou avoir retiré un masque, avant et après avoir mangé, avant et après fumé, après avoir porté des gants, avant et après un soin de leucine ou d'hôtellerie. Il doit durer entre 30 et 60 secondes. Alors, le lavage simple des mains ou le lavage au savon doux se fait en cinq étapes.

Rappelez-vous, comme les cinq doigts de la main. Commençons par la première étape qui est de mouiller les mains avec de l'eau, de prendre une quantité de savon, de savonner, de frotter

toutes les surfaces et les espaces interdigitaux, le pouce, le bord cubital des mains et de rincer, la quatrième étape, rincer toujours avec les pulpes des doigts en haut pour que les saletés descendent en bas et de sécher. Et c'est une technique qui va durer entre 30 et 60 secondes.

Ici, c'est une affiche élaborée par le Comité de lutte des infections nosocomiales de CHI Mohamed VI où on reprend les cinq étapes de lavage simple des mains en photo et la chose la plus importante que je veux ajouter ici, c'est que quand on sèche les mains, c'est avec un essuie-mains à usage unique et il faut sécher en tamponnant et pas en frottant pour ne pas abîmer la peau de nos mains et aussi c'est avec cet essuie-mains qu'on va fermer le robinet pour ne pas le contaminer nos mains avec les bactéries présentes sur le robinet et quand on termine, il faut jeter cet essuie-mains dans une poubelle sans toucher la couvercle, donc c'est une poubelle à pédales. Deuxième technique d'hygiène des mains, c'est le lavage hygiénique ou le lavage antiseptique en utilisant un savon antiseptique. Il permet d'éliminer les soyeux et les squam comme dans le lavage simple mais il réduit aussi la flore transitoire avec une réduction beaucoup plus efficace que le lavage simple des mains.

Il est indiqué avant tout au geste aseptique comme pose d'un cathéter, manipulation d'une voie veineuse, ponction lombaire, sondage urinaire, après tout geste sale ou septique, après contact avec malades colonisés ou infectés par des germes multirésistants et en cas de période épidémique avec présence d'un germe en épidémie dans le service. Le lavage hygiénique ou le lavage antiseptique se fait en 5 étapes, les mêmes étapes que dans le lavage simple, la même durée qui est de 30 à 1 minute. La seule différence c'est le produit utilisé qui est ici un savon antiseptique.

Ici c'est le lavage antiseptique des mains expliqué en photo et en étapes sur l'affiche élaborée par le comité de lutte contre les infections nosocomiales que vous allez retrouver dans les services durant votre stage. Troisième type d'hygiène des mains c'est le lavage chirurgical qui doit être pratiqué avant une intervention chirurgicale, avant un geste à très haut risque infectieux comme la pose de cathéter central, la pose d'un drain, pose d'une circulation extracorporelle. C'est une type d'hygiène des mains qui se fait en 3 étapes en 5 minutes.

La technique du lavage chirurgical est expliquée par cette affiche élaborée par le clan du CHU Mohamed VI donc c'est une technique qui se fait en 3 temps le premier temps on va mouiller les mains et les avant-bras, savonner avec un savon antiseptique les mains et les avant-bras et les frotter pendant 1 minute de chaque côté puis les rincer abondamment des mains vers les avant-bras et vous voyez les pulpes des doigts vers le haut le deuxième temps on va savonner une deuxième fois les mains et les avant-bras mais on va brosser seulement les angles 30 secondes par main et puis rincer le troisième temps on va savonner les mains et les poignets pendant 1 minute et rincer et sécher par la suite en tamponnant avec un essuie-main stérile Dernière technique d'hygiène des mains qu'on va voir dans ce cours-là c'est la friction des mains par un produit hydroalcoolique ce produit peut être soit une solution soit un gel, il est indiqué avant et après chaque geste propre que ce soit un soin médical que ce soit un soin, un examen médical,

la distribution des médicaments, une prestation hôtelière avant la pratique d'actes aseptiques comme la pose d'un cathéter court, la manipulation d'une ligne veineuse, une ponction lombaire ou la pose d'une sonde urinaire après contact avec malades colonisés ou infectés avec un germe multirésistant ces techniques doivent être pratiquées sur des mains propres parce que la solution hydroalcoolique n'élimine pas les saletés et les souillures et il se fait en 6 étapes et en 30 minutes ces techniques commencent par déposer 3 ml de la solution hydroalcoolique dans la paume de la main la première étape c'est de mettre paume contre paume et de frotter la deuxième étape c'est la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et par la suite la paume de la main gauche sur le dos de la main droite la troisième étape c'est paume contre paume et doigts entrelacés pour viser les espaces interdigitaux, la quatrième étape c'est le dos des doigts contre paume opposé avec les doigts emboîtés, la cinquième c'est la friction en rotation du pouce gauche enroulé dans la paume droite et vice versa, c'est à dire la friction en rotation du pouce droit enroulé dans la paume gauche et la sixième étape c'est friction en rotation et mouvement de va et vient avec les doigts joints on peut ajouter deux autres étapes qui consistent à la friction du bord cubital de la main et la friction des deux poignets ces six étapes sont résumées dans l'affiche que vous voyez ici élaborée aussi par le client de CHU Mohamed 6 de Marrakech et deux choses sur lesquelles je veux bien insister c'est que l'utilisation des produits hydroalcooliques avec friction de la main doit se faire sur des mains propres, visuellement propres et ça se termine par l'assèchement du produit, on n'a pas besoin d'utiliser à la fin un séchage deuxième élément des précautions standards c'est le port des gants qu'il faut porter lors de tout contact avec les muqueuses la peau lésée, le sang, les liquides biologiques, tissus objets contaminés et manœuvres invasives et lors des soins si les mains du soignant comportent déjà des lésions cutanées, il a un double intérêt c'est de protéger le patient vis-à-vis de la flore du soignant mais aussi de protéger l'utilisateur vis-à-vis des produits agressifs et des germes du patient, le port de gants doit se faire juste avant le geste à réaliser et ils doivent être retirés et le jeter immédiatement après la fin du geste il ne faut pas traîner avec dans le service ni les utiliser pour répondre au téléphone ou écrire et il faut changer les gants entre deux patients et pour un même patient lorsqu'on va passer d'un site contaminé à un site propre donc le port de gants doit être fait pour une action précisée et ne dispense pas de l'hygiène des mains, c'est-à-dire que quand on utilise les gants, c'est sur des mains propres pour lesquelles on a utilisé la technique d'hygiène adaptée et dès qu'on enlève les gants il faut pratiquer l'hygiène des mains adaptée toujours dans les précautions standards, on a l'hygiène respiratoire qui vise à limiter la transmission d'agents infectieux vers l'entourage de proximité et vers l'environnement du soin il consiste à porter un masque à toute personne que ce soit patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur ou aidant qui présente des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration l'hygiène respiratoire se fait par l'utilisation d'un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, d'éternuement et jeter ce mouchoir immédiatement après usage et ne pas le mettre dans sa poche en l'absence de mouchoir, tous ces eaux éternuées au niveau du coude ou en haut de la manche plutôt que dans la main parce que la main c'est un moyen très important dans la dissémination de ces germes respiratoires aussi il faut réaliser une

hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés et ne pas toucher les muqueuses, yeux, nez, bouche avec des mains contaminées et pour cela il faut mettre à la disposition du personnel soignant, des visiteurs et même des patients le matériel nécessaire dans les masques, les mouchoirs jetables et à utiliser dans les lieux stratégiques à côté des précautions standard d'hygiène il y a des précautions d'hygiène complémentaires qui vont aider aussi à la lutte de la transmission de l'infection associée aux soins et les précautions d'hygiène complémentaires c'est un ensemble de mesures qui vont éviter la transmission d'un agent infectieux, connu ou présumé à partir d'un patient infecté au porteur identifié à des individus non infectés et non porteurs mais réceptifs, que ce soit le patient le membre du personnel ou le visiteur les précautions d'hygiène complémentaires sont définies en fonction de l'agent infectieux et de l'infection avec risque de diffusion épidémique qu'il s'agit d'infections naturellement contagieuses ou d'agents infectieux multirésistants aux antibiotiques et le but de ces précautions c'est de faire barrière à la diffusion de l'agent infectieux à partir du patient et ou de son environnement immédiat On a trois types de précautions contacts des précautions air et des précautions gouttelettes Ici c'est un tableau qui met en évidence le type de précautions d'hygiène complémentaires à prendre en fonction du moyen de transmission ou de modalité de transmission de l'agent pathogène Par exemple pour les précautions air ils sont destinés à des germes à transmission ailleurs portés comme la tuberculose la rougeole, la varicelle sachant aussi que pour la varicelle il se transmet par voie aérienne mais aussi par contact avec les vésicules contaminées donc en plus des précautions air il faut ajouter des précautions contacts l'ozona aussi pour lequel il faut ajouter les précautions contacts les agents pathogènes à transmission par gouttelette on a la grippe, la denovirus, la coqueluche la diphtérie et autres et les agents pathogènes à transmission en contact c'est essentiellement les bactéries à transmission par contact comme en cas de colonisation en cas d'infection ontérique la diarrhée, en cas d'infection cutanée comme l'herpès, l'ozona, la gale en cas de maladie infectieuse infantile le virus respiratoire syncytial auquel il faut ajouter les précautions gouttelettes ici c'est une affiche élaborée par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de CHU Mohamed 6 qui explique les précautions complémentaires de type R et que vous allez retrouver au niveau des services donc dans cette affiche là il donne des titres d'exemple la définition de la transmission par aérosol les agents pathogènes transmissibles par voie aérienne et aussi il donne des recommandations au profit du personnel du patient et des visiteurs sur les précautions nécessaires à prendre pour éviter la transmission aérienne de ces agents pathogènes dans cette affiche aussi il y a les précautions d'hygiène complémentaires de type gouttelette on a les indications à pratiquer devant des agents pathogènes comme la coqueluche la diphtérie, la grippe et les recommandations nécessaires pour le personnel lors de l'entrée dans une chambre où il y a un malade ayant été infecté par un de ces agents là et les précautions à prendre aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de même les précautions nécessaires à ce type de patient lors de sa mouvement en dehors de la chambre ou lorsqu'il reçoit un patient ou un visiteur de même les recommandations nécessaires pour les visiteurs la dernière fiche des précautions complémentaires de type contact aussi on explique les indications à les adopter et les

recommandations nécessaires pour le personnel et pour les visiteurs